

Niveles de atención y red asistencial

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

El sistema público de salud chileno se organiza jerárquicamente en **niveles de atención**, concebidos como **eslabones de una red asistencial integrada** que garantiza continuidad, equidad y eficiencia en la atención sanitaria.

Comprender estos niveles —**primario, secundario y terciario**— es fundamental para el médico general, ya que define su campo de acción, responsabilidades, procesos de derivación y contrarreferencia, además de su rol como **coordinador del cuidado dentro de la red**.

En el contexto del **EUNACOM**, este tema es evaluado de manera frecuente porque constituye el **pilar organizativo del sistema nacional de salud**, reflejando competencias tanto clínicas como de gestión sanitaria y conocimiento de las políticas ministeriales.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Definición de red asistencial

“La red asistencial es el conjunto de establecimientos, servicios y recursos de salud organizados territorialmente, coordinados entre sí para asegurar una atención continua, integral, equitativa y centrada en las personas.”

(MINSAL, 2010; Política Nacional de Redes Integradas de Servicios de Salud, OPS/OMS)

La red funciona como un sistema **interdependiente** y **territorial**, articulado por los **Servicios de Salud**, bajo la conducción técnica de la **Subsecretaría de Redes Asistenciales** del MINSAL.

2.2. Principios orientadores de la red asistencial

1. **Continuidad del cuidado:** conexión entre todos los niveles de atención.
2. **Integralidad:** respuesta a necesidades desde la promoción hasta la rehabilitación.
3. **Equidad territorial:** acceso sin discriminación geográfica ni económica.
4. **Eficiencia:** uso racional de recursos mediante flujos de derivación adecuados.

5. **Resolutividad:** cada nivel debe resolver la mayor cantidad posible de problemas.
 6. **Participación social e intersectorialidad.**
-

2.3. Articulación jerárquica

La red chilena se estructura en tres niveles principales:

- **Atención Primaria (APS):** primer contacto, promoción y prevención.
- **Atención Secundaria:** especialidades básicas y apoyo diagnóstico.
- **Atención Terciaria:** alta complejidad y derivaciones nacionales.

Esta organización permite que la atención sea **escalonada y coordinada**, evitando duplicidades y mejorando la eficiencia del sistema.

3. Niveles de atención en el sistema de salud chileno

3.1. Primer nivel: Atención Primaria de Salud (APS)

a) Definición y funciones

La APS es el **eje estructurador del sistema** y la puerta de entrada al mismo.

Sus principales funciones son:

- Promoción de salud y prevención de enfermedades.
- Atención integral y continua.
- Resolución de patologías prevalentes.
- Detección precoz, derivación y contrarreferencia.
- Trabajo intersectorial y comunitario.

b) Establecimientos típicos

Tipo

Características

CESFAM (Centro de Salud Familiar)	Base del modelo MAIS; atención integral y trabajo con familias y comunidad.
CECOSF (Centro Comunitario de Salud Familiar)	Extensión del CESFAM en zonas semiurbanas.
Postas rurales	Atención básica, con rondas médicas y TENS.
SAPU / SAR	Servicios de urgencia primaria.

c) Enfoque operativo

- Resolutividad ≥ 80 % de la demanda.
- Trabajo interdisciplinario (médico, enfermera, matrona, psicólogo, asistente social, odontólogo).
- Gestión local por municipalidades, supervisada por los **Servicios de Salud**.

3.2. Segundo nivel: Atención Secundaria

a) Definición

Corresponde al nivel de **especialidades básicas**, al que se accede mediante **derivación desde la APS**.

Su objetivo es **confirmar diagnósticos, realizar exámenes y tratamientos específicos** y apoyar la resolución de casos complejos.

b) Funciones principales

- Atención ambulatoria especializada.
- Exámenes de apoyo diagnóstico (radiología, laboratorio, endoscopía, ecografía).
- Procedimientos quirúrgicos menores o de mediana complejidad.
- Hospitalización de corta estadía.

- Apoyo y retroalimentación a la APS mediante contrarreferencia.

c) Establecimientos típicos

- **Hospitales de baja y mediana complejidad.**
- **Centros de especialidades ambulatorias.**
- **Centros de diagnóstico terapéutico (CDT).**

d) Especialidades básicas

Medicina interna, pediatría, obstetricia y ginecología, cirugía general, psiquiatría y odontología especializada.

e) Responsabilidad del médico general

- Derivar con antecedentes clínicos pertinentes.
 - Coordinar la contrarreferencia y seguimiento.
 - Mantener comunicación con el nivel secundario.
-

3.3. Tercer nivel: Atención Terciaria

a) Definición

Nivel de **alta complejidad**, destinado a casos que requieren procedimientos especializados, tecnología avanzada o manejo multidisciplinario hospitalario.

b) Funciones principales

- Diagnóstico y tratamiento de enfermedades graves o raras.
- Cirugías de alta complejidad y trasplantes.
- Cuidados intensivos y unidades especializadas.
- Formación de recursos humanos y docencia universitaria.
- Investigación clínica.

c) Establecimientos típicos

- **Hospitales base regionales y nacionales:**

- Hospital Sótero del Río.
- Hospital del Salvador.
- Hospital Dr. Gustavo Fricke.
- Hospital San Juan de Dios.

- Centros de referencia interregional (ej. Instituto Nacional del Tórax, Instituto Nacional del Cáncer, Hospital Félix Bulnes).

d) Acceso

- Mediante derivación justificada desde el segundo nivel.
- En urgencias, puede ser directo por gravedad vital.

3.4. Flujo entre niveles

El sistema chileno está diseñado para operar en forma **coordinada y bidireccional**:

1. Derivación (referencia):

- Desde APS → Secundario → Terciario.
- Debe incluir ficha clínica, motivo, antecedentes y exámenes previos.

2. Contrarreferencia:

- Comunicación desde el nivel especializado hacia el médico de APS, con diagnóstico, manejo y plan de seguimiento.
- Garantiza **continuidad y reinserción del paciente en la red local**.

3. Retroalimentación:

- Asegura aprendizaje y gestión conjunta entre niveles.
-

4. Red Asistencial: organización y gestión

Cada **Servicio de Salud** administra una **Red Integrada de Servicios de Salud (RISS)**, que articula establecimientos públicos de su territorio.

4.1. Componentes de la red

Componente	Función
Red APS municipal	Puerta de entrada y seguimiento continuo.
Hospitales comunitarios y provinciales	Resolución de mediana complejidad.
Hospitales base regionales	Alta complejidad, referencia regional.
Red de urgencia (Samu, SAPU, SAR)	Atención inmediata, derivación oportuna.
Red de apoyo diagnóstico y terapéutico	Laboratorios, bancos de sangre, imagenología.

4.2. Gestión de la red

Basada en principios de:

- **Territorialidad.**
- **Equidad en acceso.**
- **Complementariedad de funciones.**
- **Gestión clínica compartida.**

Cada Servicio de Salud implementa un **Consejo de Integración de la Red Asistencial (CIRA)**, que coordina la relación entre niveles, establecimientos y municipios.

5. Modelo de atención y niveles de prevención

El modelo integral (MAIS) se expresa transversalmente en los niveles de atención:

Nivel	Prevención predominante	Actividades típicas
Primario	Primaria y secundaria	Promoción, educación, tamizajes, control de crónicos.
Secundario	Secundaria y terciaria	Diagnóstico y tratamiento especializado.
Terciario	Terciaria	Rehabilitación, cuidados intensivos, cirugías complejas.

6. Rol del médico general dentro de la red asistencial

6.1. En APS

- Primer contacto con la población.
- Diagnóstico y tratamiento de patologías prevalentes.
- Coordinación de derivaciones y contrarreferencias.
- Participación en promoción y prevención comunitaria.
- Gestión de casos crónicos y familias en riesgo.

6.2. En articulación de red

- Comunicación efectiva con especialistas.
- Seguimiento longitudinal post derivación.
- Participación en mesas de gestión clínica y CIRA.

6.3. En emergencias

- Capacidad para identificar casos que requieren derivación inmediata (criterios de gravedad).
 - Coordinación con SAMU y red hospitalaria.
-

7. Desafíos del sistema asistencial chileno

1. **Desigualdad territorial** en acceso a especialidades y equipamiento.
 2. **Brechas de recursos humanos** en APS y zonas rurales.
 3. **Listas de espera** para atención secundaria y terciaria.
 4. **Fragmentación** entre niveles de atención.
 5. **Débil comunicación bidireccional** en contrarreferencias.
 6. Avance hacia un modelo **más universal, integrado y centrado en las personas** (Política Nacional de Salud 2021–2030).
-

8. Errores comunes en EUNACOM y razonamientos errados

Error frecuente	Corrección
Pensar que APS depende del MINSAL	Depende administrativamente de municipios; el MINSAL da lineamientos técnicos.
Creer que la atención secundaria es solo hospitalaria	Incluye atención ambulatoria especializada.

Confundir referencia con contrarreferencia

Referencia = envío; contrarreferencia = devolución con resultados.

Suponer que los niveles son aislados

Son complementarios e interdependientes.

Considerar que la APS solo atiende patologías leves

Resuelve el 80 % de la demanda con enfoque integral.

Omitir la importancia de la continuidad del cuidado

Es pilar del modelo integral y de la red asistencial.

9. Ejemplo aplicado

Caso clínico:

Un paciente con diabetes y pie ulcerado acude a su CESFAM.

- Evaluación inicial por médico general (APS).
- Derivación a hospital de mediana complejidad (secundario) para curación avanzada y control de infección.
- Contrarreferencia posterior al CESFAM para seguimiento y control de glicemia.

☐ Ejemplo clásico de **flujo bidireccional y continuidad del cuidado en red**.

10. Normativa y documentos ministeriales

- Ley N° 19.937 de Autoridad Sanitaria (2004).
- Decreto N° 140 de 2004: Reestructura el MINSAL.
- Modelo de Atención Integral de Salud (MINSAL, 2013).

- **Política Nacional de Redes Integradas de Servicios de Salud (MINSAL/OPS, 2010).**
 - **Política Nacional de Salud 2021–2030.**
-

11. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. El sistema público chileno se organiza en **tres niveles de atención** (primario, secundario y terciario) dentro de una **red asistencial integrada**.
2. La **Atención Primaria** es la puerta de entrada, base resolutive y eje del modelo integral.
3. La **Atención Secundaria** entrega apoyo diagnóstico y terapéutico especializado.
4. La **Atención Terciaria** se orienta a la alta complejidad y referencia nacional.
5. La **continuidad del cuidado y contrarreferencia** garantizan atención integral.
6. El **médico general** es coordinador del cuidado y articulador entre niveles.
7. El conocimiento de la red asistencial y los flujos de derivación es esencial para la práctica en APS y para el **EUNACOM**.